BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CHĂM SÓC BỆNH VIÊM TAI GIỮA NUNG MỦ CẤP

Mã đề xuất CS-TMH-12; bản trình thẩm định 14/10/2026. Chưa ban hành. Biên soạn/thẩm định/phê duyệt: ……

Áp dụng chăm sóc điều dưỡng theo bệnh, gồm nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Kỹ thuật xâm lấn phải có quy trình riêng theo QĐ3023, chỉ định và người đủ phạm vi/năng lực; bộ này không cho phép điều dưỡng tự chẩn đoán hoặc quyết định điều trị.

ICD: H66.0

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh, lý do đến khám, khởi phát, bệnh nền, thuốc/dị ứng; đánh giá ABCDE, sinh hiệu, đau, ăn/nuốt, dịch vào-ra và nguy cơ té ngã theo tình trạng. Báo ngay khi khó thở, thở rít, tím, giảm ý thức, chảy máu nhiều hoặc dấu giảm tưới máu. Cận lâm sàng theo bác sĩ.

- Bệnh có sốt không ? chảy mũi nghẹt mũi không ? dịch mũi trong hay vàng đục ? đau nhức tai nhiểu không? thời gian khởi phát bao lâu? có bị mất mùi không? có đau họng hay ù tai không? có ho không? Người bệnh có sốt không? Có chảy dịch tai không

- Tiền sử bản thân : Có bệnh lý nào về TMH không? có bị viêm mũi dị ứng hay hen suyển không? có bị bệnh lý dạ dày nào không? có bị khối u nào không

- Khám đủ các bộ phận Tai –Mũi -Họng và vùng lận cận để tránh bỏ sót

Khám và xét nghiệm theo chỉ định bác sĩ, không mặc định nội soi/xét nghiệm công thức máu cho mọi người bệnh.

2. Chẩn đoán điều dưỡng

2.1.Người bệnh đau tai, sốt , chảy mũi ,chảy dịch tai do tình trạng ứ dịch hoặc viêm hòm nhĩ, viêm mũi họng tiết dịch

2.2.Có nguy cơ biến chứng; thủng nhĩ, viêm màng não, nhiễm trùng huyết

2.3.Thiếu kiến thức về bệnh

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Đặt mục tiêu cá thể và thời điểm đánh giá: hô hấp/tuần hoàn ổn định, triệu chứng giảm so với ban đầu, dung nạp ăn/uống phù hợp, không xuất hiện dấu nguy hiểm, người bệnh/người chăm sóc hiểu kế hoạch. Phân công người thực hiện và tần suất theo dõi theo nguy cơ/y lệnh.

3.1.Giảm các triệu chứng khó chịu cho người bệnh

3.2.Giảm nguy cơ xảy ra biến chứng

3.3.Cung cấp kiến thức cho người bệnh

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1.Giảm triệu chứng khó chịu cho người bệnh

- Sốt

+ Hướng dẫn người bệnh lau mát
+ Thực hiện thuốc hạ sốt theo y lệnh

- Giảm đau tai

+ Thực hiện thuốc giảm đau theo y lệnh

+ Vệ sinh răng miệng

Chăm sóc răng miệng theo tuổi và khả năng nuốt; không khí dung thường quy chỉ vì viêm tai giữa.

- Chảy mũi, nghẹt mũi

Chăm sóc mũi theo tình trạng/y lệnh; thuốc kháng dị ứng/co mạch hoặc xông/hút mũi không mặc định cho mọi viêm tai giữa.

4.2.Giảm nguy cơ xảy ra biến chứng

Theo dõi đau, sốt, sinh hiệu, sưng sau tai, vành tai vểnh, chóng mặt, liệt mặt, đau đầu/nôn hoặc giảm ý thức; báo bác sĩ ngay khi có dấu biến chứng.

4.3. Cung cấp kiến thức cho người bệnh

- Cho người bệnh ăn cháo loãng, uống sữa , nếu đau họng, ăn chậm tiêu trong ngày

- Cho người bệnh uống nhiều nước trái cây cung cấp nhiều vitamin tăng cường sức đề kháng

- Tuân thủ theo theo phác đồ điều trị

Giữ tai khô khi có chỉ định, không ngoáy tai/tự nhỏ thuốc; thuốc nhỏ phải phù hợp khi thủng nhĩ. Không coi kiêng nước đá là biện pháp điều trị.

5. Đánh giá

Đánh giá đau tai, sốt, lượng dịch, sinh hiệu, khả năng nghe và ăn uống; không chỉ đánh giá đau họng.

- Người bệnh hiểu biết về bệnh

- Bệnh ăn uống khá

Ghi kết quả theo từng mục tiêu, triệu chứng/sinh hiệu trước và sau, mức ăn uống và nhu cầu hỗ trợ; điều chỉnh kế hoạch khi chưa đạt hoặc có vấn đề mới. Không ghi chung “khỏe hơn” để thay giá trị theo dõi.

Ghi chép bàn giao và hướng dẫn sau chăm sóc

Ghi nhận định, vấn đề, mục tiêu, thuốc/can thiệp, đáp ứng và thời điểm báo bác sĩ; bàn giao ISBAR, nơi và người tiếp nhận khi chuyển. Hướng dẫn đúng đơn, lịch tái khám cụ thể và dấu nguy hiểm; yêu cầu người chăm sóc nhắc lại. Không đợi hết thuốc khi có dấu xấu đi.

Căn cứ và nội dung cần xác nhận

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . QĐ3023/QĐ-BYT dùng cho đề cương kỹ thuật khi có quy trình kỹ thuật riêng, không dùng để xác lập mọi can thiệp chăm sóc bệnh lý.

Khoa TMH xác nhận chẩn đoán/mã ICD, danh mục kỹ thuật được phép, thuốc và kế hoạch theo dõi theo tuổi. Các chẩn đoán điều dưỡng trong nguồn là gợi ý, chỉ chọn khi có dữ liệu thực tế; không mặc định mọi người bệnh đều có tất cả vấn đề.

Người thẩm định/chữ ký/ngày: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……